

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAIPE

IASMIN DE LISBOA CAMPOS

TRATAMENTO COMPENSATÓRIO EM PACIENTE CLASSE III NA FASE ADULTA

Belo Horizonte

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAIPE

TRATAMENTO COMPENSATÓRIO EM PACIENTE CLASSE III NA FASE ADULTA

Monografia apresentada ao programa de Especialização em Ortodontia do Centro Universitário FAIPE, núcleo Belo Horizonte, como parte dos requisitos a obtenção do título de Especialista em Ortodontia.

ORIENTADORA: Sandra Lello

Belo Horizonte

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAIPE

TRATAMENTO COMPENSATÓRIO EM PACIENTE CLASSE III NA FASE ADULTA

Monografia apresentada ao programa de especialização em Ortodontia do Centro Universitário FAIPE, núcleo Belo Horizonte, como parte dos requisitos para obtenção do título de especialista.

Aprovada em ____ de _____ de _____.

BANCA EXAMINADORA

Ma. Sandra Lello

Professor

Professor

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, pela concessão de força, sabedoria e perseverança ao longo de toda esta trajetória, tornando possível a concretização deste trabalho. Agradeço, também, aos meus pais, pelo incentivo constante aos estudos.

À minha amiga Bianca, registro meu sincero agradecimento pelo apoio, incentivo e presença nos momentos mais desafiadores, contribuindo significativamente para que esta caminhada se tornasse mais leve.

À professora orientadora, Sandra Lello, expresso minha profunda gratidão pela dedicação, orientação criteriosa e valiosas contribuições, essenciais ao desenvolvimento e à conclusão desta pesquisa.

Aos meus colegas de curso, agradeço pela convivência, pelas trocas de conhecimento e pelo espírito de colaboração ao longo desta jornada acadêmica.

A todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização deste trabalho, manifesto meus mais sinceros agradecimentos.

“A educação é a chave para abrir as portas de um mundo melhor.” (Oprah Winfrey)

RESUMO

As deformidades dentofaciais de Classe III comprometem tanto a função oral quanto a estética facial do paciente. O presente estudo, por meio de revisão narrativa da literatura, tem como objetivo definir a má oclusão de Classe III, discutir o tratamento compensatório, estabelecer critérios de indicação da cirurgia ortognática e apresentar os principais tipos de compensação ortodôntica em pacientes adultos. A revisão foi realizada com base em artigos científicos, livros, dissertações e teses publicados, preferencialmente, nos últimos dez anos, além de obras clássicas relevantes ao tema. A literatura indica que o tratamento compensatório da Classe III em adultos ocorre em casos leves a moderados de problemas esqueléticos e em pacientes que não se aplicam em realizar a cirurgia ortognática. Conclui-se que é tratamento viável e que parte do princípio de um bom diagnóstico e plano de tratamento, tendo foco nas características faciais e devolvendo a função e oclusão ideais para o paciente, e, o posicionamento dentário, corrigidos. Ressalta-se, ainda, a necessidade de domínio, pelo ortodontista, das técnicas de compensação mais adequadas para cada situação clínica, especialmente nos casos associados à mordida cruzada anterior, à mordida cruzada posterior e à necessidade de exodontias.

Palavras-chave: tratamento compensatório; Classe III; ortodontia; camuflagem ortodôntica.

ABSTRACT

Class III dentofacial deformities compromise both oral function and facial aesthetics. This study, through a narrative literature review, aims to define Class III malocclusion, discuss compensatory treatment, establish criteria for indicating orthognathic surgery, and present the main types of orthodontic compensation in adult patients. The review was based on scientific articles, books, dissertations, and theses published preferably in the last ten years, as well as classical works relevant to the topic. The literature indicates that compensatory treatment of Class III malocclusion in adults is mainly indicated in mild to moderate skeletal discrepancies and in patients who are not candidates for, cannot undergo, or do not wish to undergo orthognathic surgery. It is concluded that orthodontic camouflage is a viable therapeutic alternative when preceded by careful diagnosis and individualized planning, with attention to facial characteristics, function, occlusal stability, and dental positioning. The orthodontist must also master the most appropriate compensation techniques for each clinical situation, especially in cases associated with anterior crossbite, posterior crossbite, and the need for tooth extraction.

Keywords: compensatory treatment; Class III; orthodontics; orthodontic camouflage.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	PROPOSIÇÃO	3
3	REVISÃO DE LITERATURA	4
3.1	Definição de Classe III	4
3.1.1	Definições de classe III de Angle	4
3.1.2	Definição de Andrews	5
3.1.3	Definição de perfil padrão III	5
3.2	Indicação de Cirurgia Ortognática	7
3.3	Indicação de tratamento compensatório	9
3.4	Tipos de tratamento compensatório	11
3.4.1	Classe III com mordida cruzada anterior	11
3.4.2	Mordida cruzada posterior	12
3.4.3	Compensação com exodontia	13
4	DISCUSSÃO	15
5	CONCLUSÃO	17
	REFERÊNCIAS	18

1 INTRODUÇÃO

O diagnóstico do paciente é de suma importância para identificar os problemas ortodônticos e permitir que o ortodontista realize um tratamento mais assertivo. Uma das formas de avaliar o paciente é classificá-lo em classe I, II e III e avaliar quanto ao tratamento proposto para ele. Assim, segundo Zupo et al. (2011) temos que o paciente classe III de Angle é quando a cúspide méso-vestibular do primeiro molar superior está em oclusão com o sulco méso vestibular do primeiro molar inferior em pacientes com os dentes permanentes em boca.

O paciente Classe III não representa o perfil mais comum no consultório. Segundo Araújo et al. (2008), sua prevalência é de cerca de 6% em relatos clínicos na América do Norte e no Brasil, sendo um desafio para o tratamento que se resume a cirurgia ortognática ou o tratamento compensatório quando avaliamos isso em um paciente adulto. A cirurgia ortognática é uma forma de reposicionar as bases ósseas trazendo a mandíbula para a posição ideal cirurgicamente.

Por outro lado, o tratamento compensatório, ou camuflagem ortodôntica, segundo Silva et al. (2009) é comum de ser encontrado e acontece quando se é tratado os problemas dento alveolares do paciente e as condições esqueléticas permanecem, mesmo ocorrendo uma oclusão adequada.

Sendo assim, a proposta foi discorrer sobre quando fazer o tratamento compensatório em pacientes com problemas esqueléticos com avanço de mandíbula. Além disso, precisa-se avaliar quando não se pode realizar a movimentação dos dentes de forma a reposicioná-los e devemos partir para outro tratamento. Ademais, há necessidade de avaliar as consequências que esse tipo de tratamento pode causar no paciente a curto e longo prazo.

Por fim, é de suma importância podermos avaliar de forma criteriosa o tratamento compensatório, pois é algo que lidamos no dia a dia clínico dos consultórios e tem uma busca maior pelos pacientes em que tratamos devido a ser mais conservador que uma cirurgia. Além disso, é relevante saber o limite de tratar de forma compensatória e indicar a cirurgia para melhor resolver o tratamento do paciente.

Dessa forma, é ideal que o ortodontista saiba diagnosticar e saber as melhores formas de tratar para resolver os problemas dentários do paciente de forma a conseguir mascarar o problema ósseo e trazer oclusão estável ao paciente.

2 PROPOSIÇÃO

O presente trabalho realizou uma revisão de literatura narrativa sobre o tratamento compensatório do paciente classe III adulto. Foram selecionados artigos científicos publicados e livros entre os anos de 2008 e 2024, obtidos em bases de dados como SciELO, PubMed, Google Scholar e Revista Dental Press.

O objetivo dessa monografia é definir o que é classe III, estabelecer os critérios de indicação da cirurgia ortognática, deliberar sobre o tratamento compensatório e quais seriam os tipos deste.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Definição de Classe III

Existe dentro da história da ortodontia várias teorias que tratam do equilíbrio das relações dentárias e padronizam a face e dentição de acordo com estudos e medidas. Dessa forma, segundo Capellozza Filho (2004) para definir uma conduta em relação ao crescimento e definir um padrão morfogenético foi se criado um conjunto de objetivos para direcionar os tratamentos ortodônticos. Com isso, há as definições de posicionamento dentarias e os padrões de classe I, II, III, face longa e curta.

Sendo assim, a Classe III, segundo Ferreira et al. (2014) é um desvio da parte esquelética de característica anteroposterior que acomete cerca de 3% a 13% de toda a população tendo maior predominância asiática por deficiência de maxila. Com ISS, pode-se perceber uma prevalência baixa na população, pois “4% parece ser mais consensual entre clínicos na América do Norte e no Brasil” (FERREIRA et al., 2014, p. 46).

3.1.1 Definições de classe III de Angle

Um dos primeiros a fazer uma definição sobre a classificação das más oclusões dentárias foi em 1899. Assim, Angle observou que o primeiro molar permanente tem uma posição estável no esqueleto crânio facial humano e mal posicionado causava alterações anteriores na arcada dentária (FERREIRA, 2008).

Sendo assim, segundo esse mesmo autor, as Classes de má oclusão foram divididas em I, II e III, essa classificação se partiu das observações quanto a posição do molar feita por Angle. Dessa forma, para se dizer que um paciente está na classificação de classe III, observando somente a posição do molar, temos que segundo Ferreira (2008) são más oclusões em que o primeiro molar inferior está com sulco para a mesial em relação a cúspide mesio-vestibular do molar superior.

Dessa, forma segundo Azenha e Maclufe Filho (2008) a classificação de Angle é usada até os dias atuais para avaliação de problemas dentário antero-posteriores da arcada, mesmo que para um diagnóstico mais preciso deva-se olhar outros fatores. Já que com

o evoluir dos conhecimentos, a classificação proposta por Angle foi modificada, por não incluir fatores como a relação entre maxilares e o padrão de crescimento, característicos de cada paciente. (RIBEIRO,2019, p.4)

Também pode-se destacar que a classe III pode ter uma subdivisão segundo Azenha (2008) quando somente um dos molares está em classe III e o outro está em classe I, surge a subdivisão. Com isso, o lado da má oclusão dita se a subdivisão é direita ou esquerda, por exemplo, se o lado esquerdo estiver em classe III, o diagnóstico se dá em paciente classe III subdivisão esquerda, o que subentende que o lado direito está em classe I.

3.1.2 Definição de Andrews

A definição de classe III sofreu modificações e acréscimos ao longo dos anos e um dos autores mais importante quanto a essas mudanças foi, segundo Capellozza Filho (2004), em 1972 com Andrews que definiu a relação sagital dos arcos de acordo com os pré-molares. Assim, “As Seis Chaves de Oclusão Normal de Andrews, propõem características fundamentais de uma oclusão dentária sob o ponto de vista morfológico.” (ARIZPURÚA, 2019, p. 10).

Sendo assim, para Capellozza Filho (2004) chama-se de indivíduos Padrão III, os portadores das más oclusões resultantes de degrau sagital diminuído entre maxila e mandíbula. Nesse padrão, estão inclusos os portadores de retrusão maxilar ou prognatismo independente da relação molar que seus arcos dentários apresentarem.

3.1.3 Definição de perfil padrão III

O perfil padrão III segundo Capellozza Filho (2004) é um conjunto de características faciais dos indivíduos classe III que variam entre a retrusão maxilar e prognatismo mandibular, sendo que 2/3 dos casos tem uma predominância deficiência da maxila. Dessa forma, temos que segundo Souza et al. (2020) o padrão facial III tem perfil reto com convexidade facial por causa da deficiência de

maxila, ou projeção da mandíbula ou ambos os fatores, com um degrau sagital negativo entre maxila e mandíbula e o lábio inferior na frente do superior.

Complementando o exposto acima vemos que

O terço inferior da face tende ao aumento, principalmente no prognatismo, e a linha queixo-pescoço apresenta-se normal nos deficientes maxilares ou em excesso nos prognatas. (REIS et al., 2006, p. 36)

Além disso, há uma aparência de deficiência do terço médio facial, mesmo estando normal, pois o excesso de mandíbula projeta o tecido mole e mascara a região zigomática, segundo Capelozza Filho (2004).

3.2 Indicação de Cirurgia Ortognática

Para se tratar o paciente Classe III, segundo Ferreira et al. (2014) depende de vários fatores como qual a fase de crescimento está, colaboração do paciente, se é hereditário e estruturas anatômicas envolvidas. Dessa forma, tem-se que

pacientes, que não foram tratados precocemente ou apresentaram recidiva do tratamento precoce durante a fase de surto de crescimento, muitas vezes recorrem ao tratamento ortodôntico na dentadura permanente (FERREIRA et al., 2014, p.46)

Para se indicar a cirurgia ortognática é preciso que haja segundo Tavares et al. (2005) um planejamento da ortodontia antes da cirurgia para se corrigir os problemas de comprimento do arco de modo a alinhar, nivelar e corrigir o giro de dentes. Além disso, temos que avaliar que

indivíduos padrão III cirúrgicos mandibulares caracterizam-se por: compensação dental para a má oclusão referida, processo alveolar da sínfise mandibular acompanhando a inclinação lingual do incisivo inferior e lingualização do processo alveolar, curvaturas menos pronunciadas da cortical óssea vestibular da sínfise mandibular, mento ósseo mais pronunciado, valores diminuídos das espessuras do processo alveolar, altura da sínfise similar ao normal, e baixos valores das proporções cefalométricas da sínfise mandibular. (ZUPO et al., 2011, p. 39).

Sendo assim, segundo Tavares et al. (2005) há alterações vistas na cefalometria como uma diminuição da base do crânio, em que o ponto cefalométrico “naso” está posterior e vemos a altura facial posteriores nessa mesma condição colocando o ponto “porio” mais inferior, dificultando a mensuração dos ângulos e as tornando inadequada para a análise.

Dessa forma, as “características morfológicas associadas a este tipo de má oclusão devem ser levadas em consideração no planejamento ortodôntico e cirúrgico.” (TAVARES et al., 2005, p. 109). Ao sintetizar os quesitos necessários, segundo Capellozza (2015) os pacientes eleitos para cirurgia precisam ter discrepância esquelética severa e os incisivos tanto superiores quanto inferiores já estarem compensados. Assim, são pacientes que já tem uma compensação natural dos dentes e mesmo com isso possuem uma discrepância óssea visível.

Além disso, destaca-se que na literatura

o paciente deve expor cerca de 3 mm do dente incisivo superior e de 3 a 4 mm de gengiva inserida no sorriso. A mentoplastia é um recurso auxiliar

muito usado simultaneamente à cirurgia ortognática e pode ser de fundamental importância para o sucesso do resultado estético obtido. (SILVA et al., 2009, p. 130)

Portanto, “a terapia cirúrgica produziria um melhor resultado estético ao perfil do que a simples compensação ortodôntica.” (FERREIRA et al., 2014, p. 46). Complementando, segundo Santos et al. (2012), a cirurgia ortognática envolve também função, de forma a melhorar a mastigação, fala, respiração e a parte estética harmonizando e equilibrando a face.

3.3 Indicação de tratamento compensatório

Quando pensamos em um tratamento para compensar um problema ósseo trabalhando de forma focada na correção somente dos dentes, em “tratamentos nos quais a severidade é leve ou moderada e a opção do paciente por um tratamento não cirúrgico” (FERREIRA et al., 2014, p.50). Dessa forma, a opção é o tratamento compensatório, também chamado de camuflagem ortodontia, que segundo Almeida et al. (2016) não altera a desarmonia das bases ósseas e muito menos o perfil facial.

O tratamento compensatório segundo Marques et al. (2019) é uma opção para os pacientes que tem receio de uma cirurgia ou não tem condições de arcar devido ao custo. Além disso, tem-se que

o tratamento não-cirúrgico de uma má oclusão de Classe III é, essencialmente, uma camuflagem que possibilita uma melhor harmonia da face. (ARAUJO et al., 2008, p. 130)

Dessa, forma é possível se conquistar uma melhora dos problemas de encaixe dentário com uma correção mais conservadora.

Em adição a esse fato, “a proposta de um tratamento compensatório procura mascarar a discrepância esquelética com a alteração, principalmente, no posicionamento dos dentes anterossuperiores e ântero-inferiores” (FERREIRA et al., 2014, p.49). Assim, segundo Marques et al. (2019), o tratamento compensatório permite fechar a mordida e alcançar um trespasse vertical positivo.

Além disso, pode-se dizer que a

camuflagem no tratamento da Classe III inclui uma rotação no sentido horário da mandíbula, uma proclinação dos incisivos superiores e uma retroinclinação dos incisivos inferiores. Esse processo deve ser determinado pela possibilidade de um selamento labial passivo (Araujo et al., 2008, p.136).

Deste modo, de acordo com a literatura esse tratamento proporciona movimentos dentários em busca de uma melhora no encaixe dos dentes para compensar os problemas esqueléticos.

Assim, questiona-se qual seria o limiar para poder avaliar um paciente e definir se o ortodontista irá fazer uma compensação? Essa resposta, segundo Marques et al. (2019), depende do grau da discrepância, tamanho do nivelamento e

alinhamento dentário, se vai precisar de exodontia e o tanto que a arcada inferior vai precisar distalizar.

Pode-se observar que segundo Capellozza Filho (2004) para se tratar o paciente classe III precisa-se excluir os pacientes que são prognatas ou se for, se enquadra em moderado, a maxila com deficiência relativa. Assim, quase todos os pacientes que não se enquadrem neste quesito podem ser tratados de forma compensatória.

3.4 Tipos de tratamento compensatório

O tratamento de compensação para o paciente classe III precisa antes partir do princípio de qual problema esse paciente possui, se é uma protusão mandibular, uma retrusão maxilar ou ambos os problemas. Dessa forma,

muitos casos de má oclusão de Classe III esquelética suave, que não necessitem de tratamento cirúrgico, poderiam ser resolvidos apenas com a compensação dentária ao final do tratamento e, para que isso ocorra, seria necessária uma individualização do caso, já que cada paciente possui características esqueléticas e dentárias únicas (AZEVEDO, 2010, p. 109)

Assim, o tratamento varia de acordo com a área de atuação, se será ou na mandíbula, ou na maxila, ou em ambos.

3.4.1 Classe III com mordida cruzada anterior

A mordida cruzada pode ser segundo Rodriguez Yáñez et al. (2018) por retrusão da maxila ou protrusão da mandíbula ou por uma combinação de ambos e quando afeta um ou vários dentes isolados, pode-se inferir que é um problema dentário com palatinização dos incisivos superiores e vestibularização dos inferiores.

Para descruzar a mordida por problema dentário, pode-se utilizar, segundo Rodriguez Yáñez et al. (2018), o aparelho fixo com um fio de NiTi de arco reto e mola aberta para criar um deslocamento do arco e deslocamento dentário para a posição apropriada. Isso deve ser feito primeiramente no arco superior e não instalando o inferior para não haver o alinhamento prematuro e dificultar na mecânica.

Seguindo a mecânica, faz-se um torque negativo nos dentes inferiores anteriores colocando a posição da raiz para a vestibular, essa mecânica pode ser feita colando o braquete invertido (180°) colocando os arcos de aço 18X25 ou 19X25 ou também se pode fazer as dobras de 3ª ordem no fio de arco principal.

Além disso, segundo Rodriguez Yáñez et al. (2018) põe-se utilizar a técnica de arco expandido colocando o arco principal de aço com a espessura de 0,018 ou 0,020 há uma distância de 2 mm do slot do braquete superior. Como complemento, pode-se fazer uma dobra em Ômega na mesial do tubo dos molares o que ajudaria a empurrar os dentes para vestibular e impediria que o arco deslize.

Além do aparelho fixo é necessário utilizar complementos para mecânica que, segundo Rodriguez Yáñez et al. (2018), são os bite-block que podemos utilizar para

fazer o levantamento da mordida e facilitar no descruzamento da mordida. Esses dispositivos podem ser fixos com a colagem de resina diretamente no dente ou removíveis e precisam ser utilizados até que se corrija o cruzamento da mordida.

Outra técnica que se pode utilizar para realizar a compensação da classe III chama-se

técnica biofuncional se diferencia de outras técnicas por apresentar um torque de forma a realizar um efeito de resistência aos efeitos colaterais promovidos pelos elásticos de classe III utilizado na compensação desta má-oclusão. (FERREIRA et al., 2014, p. 46)

Segundo Ferreira (2008) pode-se utilizar a técnica Bifuncional montando o aparelho superior e inferior utilizando elástico desde o início para descruzar a mordida, com o uso de botões colados na face palatina do incisivo central inferior e nos ganchos dos braquetes dos incisivos centrais superior, para ajudar a descruzar a mordida.

Assim, o elástico fica em forma de Z e muda o posicionamento das coroas dentárias para compensar a má oclusão e posiciona os dentes de forma correta. Dessa forma, pode-se notar um papel importante no uso destes dispositivos, pois a

ação dos elásticos, o esperado é que exista uma remodelação dentoalveolar levando o osso alveolar da maxila para anterior e da mandíbula para posterior. Além disso, espera-se também uma inclinação para vestibular dos incisivos superiores e para lingual dos incisivos inferiores. Normalmente os pacientes com má oclusão de Classe III já apresentam uma inclinação dos incisivos superiores para vestibular e dos inferiores para lingual e o uso dos elásticos apenas acentua mais ainda situação.' (ANGHEBEN, 2018, p. 25).

Com isso, acentuamos mais a compensação já existente do paciente com o uso de mecânica ortodôntica compensatória e elásticos de classe III.

Como complemento da finalização e uso de elástico “a manipulação da angulação dos caninos seria uma peça importante na compensação ortodôntica do erro esquelético.” (AZEVEDO, 2010, p.110). Dessa forma, segundo Azevedo (2010) há uma modificação na angulação dos braquetes colocando 11° para os caninos superiores e 0° para os inferiores nos casos de classe III. Esse complemento permite aumentar o trespasse superior e seduzir o arco inferior permitindo uma maior compensação.

3.4.2 Mordida cruzada posterior

No paciente adulto é feito, segundo Rodriguez Yáñez et al. (2018), uma inclinação dos molares e pré-molares superiores e inferiores com a utilização de arcos de expansão na parte superior. Já na parte inferior utilizamos os arcos de contração para evitar a vestibularização e expansão inferior.

Outro dispositivo que auxilia na mecânica do aparelho fixo são os elásticos que, na visão de Rodriguez Yáñez et al. (2018), pode-se usar em forma de Z em que se coloca na região palatina dos dentes superiores a vestibular dos dentes inferiores que precisam ser descruzados. Essas ligas são de diâmetro de 1/8 e são complementados pela colagem de botões na palatina dos dentes superiores para ajudar a colocar os elásticos

3.4.3 Compensação com exodontia

Para se definir quando iremos realizar a exodontia de dentes para a compensação do paciente classe III,

tem-se que muitas vezes, por razões de discrepância de modelos ou mesmo cefalométrica, bem como a presença, não rara, de um trespasse vertical negativo, conduz a um planejamento com extrações de dentes inferiores (FERREIRA et al., 2014, p. 49).

De acordo com a conduta adotada, conforme Araujo (2008), pode-se adotar a extração de primeiros pré-molares inferiores; extração de segundos pré-molares superiores e primeiros pré-molares inferiores; extração de um incisivo inferior e extração de primeiros molares inferiores. Dessa forma, “uma dessas opções pode ser adotada, dependendo do diagnóstico e da observação dos diferentes casos”. (ARAUJO, 2008, p. 143)

Quando o efeito é compensatório, segundo Janson (2008), haverá uma discrepância antero-posterior de 3mm ou mais, assim pode-se extrair os pré-molares ou molares. Dessa forma,

a escolha recai sobre os pré-molares, a finalização será de canino em Classe I e molares em Classe III. Se o dente extraído é o molar, a finalização nos caninos será a mesma e nos molares haverá um relacionamento de Classe I entre o primeiro molar superior e o segundo molar inferior.” (JANSON, 2008, p. 447-448)

Sendo assim, a opção para a correção da classe III com exodontia é uma forma viável e deve ser avaliada de acordo com o tamanho de ganho necessário para a correção da discrepância.

Após a exodontia, pode-se utilizar segundo Almeida et al. (2016) os mini-implantes para ancoragem extra-alveolar de retração da bateria dentária inferior, após as extrações, dos dentes mais comuns, os primeiros pré-molares inferiores.

4 DISCUSSÃO

Alguns autores apontam a definição da Classe III de formas diferenças, quando analisamos a classificação de Angle em 1899, Ferreira (2008) diz que foi uma observação da importância do primeiro molar permanente para a estabilidade do esqueleto crânio facial. Além disso, tem-se que é uma má oclusal em que o primeiro molar inferior está com sulco para a mesial em relação a cúspide mesio-vestibular do molar superior.

Por outro lado, ao longo dos anos essa classificação sofreu modificações até Andrews em 1972, que segundo Capellozza Filho (2004) indivíduos Padrão III são caracterizados por uma relação sagital de arcos avaliados pelos pré-molares. Além disso, há um degrau sagital diminuído na relação de máxima e mandíbula com uma retrusão de maxila e protusão de mandíbula.

Em contrapartida a classificação mais utilizada é o perfil facial que para o padrão III de acordo com Capellozza Filho (2004) são características facial englobam a classe III, mas vão além disso. Concordando com essa posição, Reis (2006) acrescenta que há um perfil reto com convexidade facial, deficiência de maxila ou projeção de mandíbula ou ambos os casos, aumento do terço inferior facial e Capellozza Filho (2004) complementa que há uma deficiência no terço médio facial, mesmo estando normal devido a grande evidencia da mandíbula.

Quando se pensa em tratamento Ferreira et al. (2014) e Tavares et al. (2005) concordam que é preciso um bom planejamento, diagnóstico, colaboração do paciente para se conseguir resolver o problema do paciente. Assim, ambos quando indicam o tratamento cirúrgico relatam que são pacientes já compensados dentariamente.

Além do exposto acima, Capellozza (2015) acrescenta que aos pacientes para cirurgia devem ter uma discrepância esquelética severa e essa questão refletida de forma dentária seria dita por Silva et al. (2009) com cerca de 3 mm de exposição de incisivo inferior e 3 a 4 mm de gengiva inserida. Com isso, Ferreira et al. (2014) e Santos et al. (2012) concordam que a ortognática melhora a estética facial, função mastigatória, fala, respiração e harmonia no equilíbrio facial.

Por outro lado, há um tratamento mais conservador para o paciente classe III que segundo Ferreira et al. (2014) e Almeida et al. (2016) não altera os problemas ósseos e são para casos leves a moderados e acrescentando a isso, Marques et al.

(2019) é uma opção para quem não quer fazer o processo cirúrgico que Araujo et al. (2008) chama de camuflagem. Sendo assim, Ferreira et al. (2014), Marques et al. (2019) e Araujo et. al. (2008) concordam e dizem que a camuflagem ortodôntica corrige discrepâncias esqueléticas com alteração de dente no sentido anteroposterior, permite fechar a mordida, faz uma retração dos incisivos inferiores e protusão dos superiores possibilitando um selamento labial passivo.

Para se fazer isso, há algumas formas e envolve segundo Azevedo (2010), Tavares et al. (2005) e Ferreira et al. (2014) no bom diagnóstico e individualização de cada caso. Quando o diagnóstico de classe III é com mordida cruzada anterior Rodrigues Yáñez et al. (2018); Ferreira et al. (2014) e Ferreira (2008) concordam na técnica biofuncional, utilizando braquetes pré-programados, elásticos de classe III, fios de arco expandido superior para descruzar a mordida.

Outro diagnóstico é quando há mordida cruzada posterior, em que Rodrigo Yáñez et al. (2018) acrescenta na técnica supracitada o uso de elásticos em Z coloca na região palatina dos dentes superiores a vestibular dos dentes inferiores que precisam ser descruzados. Além disso, há o diagnóstico com exodontia em que Ferreira et al. (2014), Araújo (2008) e Janson (2008) concordam que pode ser de pré-molares inferiores ou incisivo central inferior sendo necessário uma discrepância de 3 mm ou mais e acrescido por Almeida et al. (2016) de uma ancoragem para retração de mini-implantes

Diante do exposto, observou-se que a literatura apresenta consenso quanto à importância do diagnóstico adequado e do planejamento interdisciplinar no tratamento das deformidades dentofaciais classe III. Os autores citados corroboram com a opinião de que o tratamento compensatório é bastante viável em casos leves a moderados e proporcionam uma correção dentária e devolve a oclusão correta, mas dependem de uma análise individualizada de cada paciente e da colaboração dele, bem como de um estudo aprofundado das técnicas pelo profissional.

5 CONCLUSÃO

Considerando tudo que foi abordado, pode-se perceber que a Classe III foi definida por Angle e Andrews com foco na posição dentária em que há uma projeção dos dentes inferiores e uma retração dos superiores e isso reflete no perfil facial do portador dessa discrepância. Dessa forma, há uma retrusão maxilar ou projeção mandibular ou ambos os fatores, em que nota-se um aumento do terço inferior e deficiência do terço médio da face.

Para se tratar essa condição esquelética, há a possibilidade da cirurgia ortognática, que para indicação encaixa-se os pacientes não tratados precoces, recidiva, os que já possuem uma compensação dentária e discrepâncias ósseas acentuadas. Para isso, é preciso de um diagnóstico baseado em exames cefalométricos, colaboração do paciente, avaliar as estruturas envolvidas e um planejamento ortodôntico pré- cirúrgico.

Outra opção de tratamento é a camuflagem ou compensação ortodontia que consiste em corrigir um problema esquelético de forma dentária, para isso é preciso que a discrepância esquelética classe III seja leve, o paciente não optar por cirurgia, pois não se altera o perfil facial. Sendo assim, o tratamento consiste em uma retração dos incisivos inferiores e protusão dos superiores finalizando com o selamento passivo labial do paciente.

Para que a compensação ocorra, é preciso avaliar se há mordida cruzada anterior e posterior, se irá realizar exodontia. Dessa forma, há a utilização de braquetes diferenciados para a correção da classe III associados a fios de arco expandido superior e *bite block* com o uso de elásticos para auxiliar na mecânica. Além disso, quando se planeja a exodontia, pode-se realizar dos pré-molares inferiores ou um incisivo central inferior associação de mini implantes para ancoragem extra-alveolar

Diante de todo o exposto, o tratamento compensatório de classe III em adultos é um tratamento muito viável para casos que o paciente não possa fazer a cirurgia ortognática, queira algo mais conservador sem que interfira nas características faciais. Dessa forma, para o sucesso é preciso uma anamnese e diagnóstico preciso e domínio das técnicas ortodontias que seriam mais viáveis para cada paciente sendo planejado individualmente para cada caso.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcio Rodrigues de; ALMEIDA, Renato Rodrigues de; CHANG, Chris. **Biomecânica do tratamento compensatório da má oclusão de Classe III utilizando ancoragem esquelética extra-alveolar.** *Clinical Orthodontics*, v. 15, n. 2, 2016.

ANGHEBEN, Christian Zamberlan. **Comparação dos resultados cefalométricos obtidos com cirurgia ortognática e tratamento compensatório em pacientes classe III.** 2018. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

ARAÚJO, Eustáquio A.; ARAÚJO, Cristiana V. de. **Abordagem clínica não-cirúrgica no tratamento da má oclusão de Classe III.** *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, [s. l.], v. 13, n. 6, p. 128-157, dez. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dpress/a/byzkrcVVzjd35kM8Ms9QzwC/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 2 set. 2025.

ARIZPURÚA, Alexa Nicole Guerreiro. **Principais aspectos de finalização ortodôntica levando em consideração aspectos oclusais e estéticos.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2019.

AZENHA, Claudio R.; MACLUFE FILHO, Eduardo. **Protocolos em Ortodontia: diagnóstico, planejamento e mecânica.** São Paulo: Napoleão, 2008.

AZEVEDO, Lucyana Ramos; TORRES, Tatiane Barbosa; NORMANDO, David. **Angulação dos caninos em indivíduos portadores de má oclusão de Classe I e de Classe III: análise comparativa através de um novo método utilizando imagens digitalizadas.** *Dental Press Journal of Orthodontics*, [s. l.], v. 15, n. 5, p. 109-117, out. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dpjo/a/NXfYxMy5Ntk8HMKSRPXdQqS/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2026.

CAPELOZZA, Guilherme Milanese. **Compensação nas más oclusões Classe III: avaliação da inclinação das coroas dentárias por meio de modelos digitais.** 2015. Dissertação (Mestrado em Odontologia – Área de Ortodontia) – Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 2015.

CAPELOZZA FILHO, Leopoldino. **Diagnóstico em ortodontia.** Bauru: Dental Press, 2004.

FERREIRA, Flávio Vellini. **Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico.** 7. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2008.

FERREIRA, Renato Adriano Coelho; BANDECA, Adriano Garcia; ANDRADE JR., Pedro; SOUZA, José Eduardo Prado de; FREITAS, Karina Maria Salvatore de; CANÇADO, Rodrigo Hermont; VALARELLI, Fabrício Pinelli. **Tratamento não-**

cirúrgico da Classe III com a técnica biofuncional em paciente adulto jovem. *Revista Uningá*, Maringá, v. 41, p. 45-51, ago./out. 2014.

JANSON, Marcos. **Ortodontia em adultos e tratamento interdisciplinar.** Maringá: Dental Press, 2008.

MARQUES, Mariane Nunes Nascimento Moutinho; CORREIA, Ana Paula Zaia Barel; KAMODA, Diogo Mamoru; SOUZA, Edson Ramos; SHIBUYA, Ronaldo Henrique. **Tratamento compensatório sem exodontia de malocclusão de Classe III.** 2019. Monografia (Especialização em Ortodontia) – UNINGÁ, Maringá, 2019.

REIS, Sílvia Augusta Braga; ABRÃO, Jorge; CAPELOZZA FILHO, Leopoldino; CLARO, Cristiane Aparecida de Assis. **Estudo comparativo do perfil facial de indivíduos Padrões I, II e III portadores de selamento labial passivo.** *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, [s. l.], v. 11, n. 4, p. 36-45, ago. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dpress/a/BfXQ3JVK9TZhzpb3Nm8MtRc/?format=html&lang=p> t. Acesso em: 10 mar. 2026.

RIBEIRO, Joana Catarina Conde. **Camuflagem Ortodôntica de Classe III: caso clínico.** 2019. 29 f. Tese (Doutorado) - Curso de Odontologia, Medicina Dentária, Coopertiva de Ensino Superior Politécnico e Universitário, [S.L.], 2019. Disponível em: <https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/3210>. Acesso em: 04 set. 2025.

RODRIGUEZ YÁÑEZ, Esequiel E.; CASASA ARAUJO, Rogelio; NATERA M., Adriana C. **1.001 dicas em ortodontia e seus segredos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Quintessence, 2018.

SANTOS, Mariana Rodrigues Machado dos; SOUSA, Cristina Silva; TURRINI, Ruth Natalia Teresa. **Percepção dos pacientes submetidos à cirurgia ortognática sobre o cuidado pós-operatório.** *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, [s. l.], v. 46, p. 78-85, out. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/6DNVtNTdmbpKtDzdZcmfSrb/?lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SILVA, Alexandre Augusto Ferreira da; MANGANELLO-SOUZA, Luiz Carlos; FREITAS, Sonia Luisa de Almeida. **Tratamento das deformidades maxilofaciais.** *Revista Brasileira de Cirurgia Craniomaxilofacial*, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 129-132, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361036223_Tratamento_das_deformidades_maxilofaciais. Acesso em: 2 set. 2025.

SOUZA, Rhayane Coelho Santos; PEREIRA, Daniela Porto da Cunha. **AValiação DO PERFIL FACIAL QUANTO A AGRADABILIDADE E ESTÉTICA.** *Arquivo Brasileiro de Odontologia*, [S.L.], v. 16, n. 2, p. 38-44, 2020. Disponível em: <https://share.google/77BFvCMZPyilcftFJ>. Acesso em: 04 set. 2025.

TAVARES, Hewerson Santos; GONÇALVES, João Roberto; PINTO, Ary dos Santos; RAPOPORT, Abrão. **Estudo cefalométrico das alterações no perfil facial em pacientes Classe III dolicocefálicos submetidos à cirurgia ortognática**

bimaxilar. *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, [s. l.], v. 10, n. 5, p. 108-121, out. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dpress/a/c9N44hpktDvq4sZThxLqzXt/?lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2026.

ZUPO, Déborah Gazal; BENEDICTO, Eduardo de Novaes; KAIRALLA, Silvana Allegrini; MIRAND, Sérgio Luís de; CÉSA, Carla Patrícia Hernandez Alves Ribeiro; PARANHO, Luiz Renato. **Características morfológicas e o tratamento ortodôntico para o padrão III facial.** *Revista Brasileira de Cirurgia Craniofacial*, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 38-43, 2011.